

抗抑郁症药物不良反应及药物相互作用

刘 勤

(重庆市巴南区中医院 重庆 401320)

摘要:抑郁症属于精神科常见疾病,目前并无特效的根治药物,一般需要长期坚持药物与行为治疗等,才能取得一定的效果。从近几年相关研究及临床实践来看,抗抑郁症药物较多,比如三环类(TCAs)、单胺氧化酶抑制剂(MAOI)、选择性去甲肾上腺素(NE)、选择性5-羟色胺(5-HT)、NE能和特异性5-HT能抑制剂(NaSSA)等。虽然这些抗抑郁药物能取得一定的疗效,但是大部分药物都有一定的不良反应,而且存有药物相互作用。为了进一步分析抗抑郁药物不良反应及药物相互作用,本文就几种常用抗抑郁药物进行了分析,希望对相关工作有所借鉴。

关键词:抗抑郁症;不良反应;药物相互作用;分析

【中图分类号】R96

【文献标识码】A

【文章编号】1009-6019(2014)09-0113-01

抑郁症属于精神科常见疾病,近几年相关报告来看,其发病率呈现逐年上升趋势,而且在中老年人中发病率较高。随着研究的深入,目前已有多种抗抑郁药物应用在临床中,比如选择性5-羟色胺(5-HT)、NE能和特异性5-HT能抑制剂(NaSSA)等^[1],而三环类抗抑郁药物属于老一代抗抑郁症药物,其不良反应普遍较重,已经逐渐被新药物取代,但在临床中依旧有所应用,必须联用药物时可降低其不良反应^[2]。为了进一步分析抗抑郁症药物不良反应及药物相互作用,本文就几种常用抗抑郁药物进行了分析,现介绍如下。

1 三环类抗抑郁药物(TCAs)

三环类抗抑郁药物是国内最为广泛应用的抗抑郁药物,作用机制主要在于阻断去甲肾上腺素与多巴胺的再摄取,同时进一步提高突触间的含量,进而起到抗抑郁的效果。但是,临床实践中其存在不良反应与毒副作用及药物相互作用,现分析如下:

1.1 不良反应:三环类抗抑郁药物常见不良反应主要有便秘、口干、尿滞留、视物模糊、体重增加及嗜睡等,主要是因为抗胆碱能作用与抗组胺作用的结果,同时还与药物的浓度有关,不同的浓度可能存有较大个体差异^[3]。对于轻度的不良反应一般无需特殊处理就能自行缓解,若有必要可采取少量拟胆碱药物处理。

1.2 毒副作用:三环类抗抑郁药物常见毒副作用为中枢神经系统毒性与心血管系统毒性,前者表现有注意力不集中、情绪下降、震颤、社会行为异常、运动失调、幻觉妄想、癫痫发作、焦虑不安、昏迷及意识模糊等,基本上与血药浓度相关,若浓度过高(一般为 $>150\mu\text{g/L}$),癫痫发作可能性极高。TCAs类药物诱发的癫痫发作主要表现为单项强直阵挛性大发作,并且能持续数分钟。基于此,在临床应用中,若察觉TCAs的血药浓度较高,则应适当减量处理,尽量将其控制在合理的血药浓度内。后者表现则有传导阻滞、直立性血压心动过速、心律失常、心悸骤停等^[4],主要和受体敏感性相关,其中低血液浓度也极易发生,在患有充血性心衰及老年患者中比较好发。TCAs导致的心律失常往往与其具有奎尼丁样膜稳定相关,除了心动过速外,基本上都和血药浓度升高相关,为此对于含有心脏传导阻滞的患者而言则不宜采取该药物。

1.3 药物相互作用:研究显示,多种药物对三环类抗抑郁药物血压浓度都有一定的影响,比如利福平、卡马西平、格鲁米特、苯巴比妥及口服避孕药等,这些都有可能诱导羟化酶与增强三环类抗抑郁药物代谢,从而降低血药浓度;而雌激素、甲状腺素、奋乃静、氯化可的松等则会抑制三环类抗抑郁药物的代谢作用,从而促使血药浓度提高。此外, β 受体阻滞剂与西咪替丁可能利用降低肝脏血流与减慢TCAs代谢等过程,促使血药浓度的升高。

2 5-HT₁NE再摄取抑制剂(SNRI)

选择性去甲肾上腺素(NE)、选择性5-羟色胺(5-HT)抗抑郁效果主要是通过文拉法辛(万拉法辛)显著抑制前述两种药物的回收而发挥抗抑郁作用,但是对于单胺氧化酶却无明显的抑制效果。万拉法辛与组胺能、胆碱能及肾上腺素受体之间无亲和力,故而无中介相关副作用(如便秘、镇静、尿滞留、口干等)。从多年的临床研究来看,本品有着和传统三环类抗抑郁药物相似的药理作用,有着不良反应少与起效快等优势,有着很好的应用前景。

2.1 不良反应:研究显示,若短期内应用30~450mg/d文拉法辛耐受性良好的患者,其不良反应较少,有的话基本以温和为主,而且发生于治疗早期,同时存有剂量相关性。在持续的治疗中可以逐步减轻,常常表现出盗汗、恶心、失眠、嗜睡及头昏等,但皆能自行消失。

2.2 药物相互作用:文拉法辛与单胺氧化酶抑制剂联用将会产生十分严重的副作用,甚至致命,因此对于单胺氧化酶抑制剂治疗的患者需要采取本品治疗则应在前者治疗两周后再用本品;而应用本品的患者则应停药一周后才能服用单胺氧化酶抑制剂。此外,对于高血压或者肝功能损害的患者,西咪替丁与本品联用在一定程度上可降低清除率。此外,本品对细胞色素P450 II D6酶有一定的抑制效果,故而可能存在与其他通过此酶代谢药物作用的可能。

3 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂属于抗抑郁新型药物,流行于20世纪

90s,而当时在国内也大力推广应用。其中该类药物首创药为氟西汀,后来逐渐发展了帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰、氟伏沙明等,这些药品的治疗效果比较相似,但是出现的大部分不良反应却不同,现分析如下:

3.1 不良反应:氟西汀属于SSRIs首创药,治疗过程中并无三环类抗抑郁药物的低血压与抗胆碱能效应,而且出现嗜睡、镇静、震颤及出汗等不良反应发生率皆要明显比三环类抗抑郁药物更低,其主要的不良反应基本上以恶心、体重减轻、厌食、神经质、焦虑、震颤、失眠及性功能障碍等为主,此外氟西汀治疗时若过量则可能发生癫痫发作,但一般不会对心血管功能产生影响,而老年患者中则可能引发心律失常与晕厥等^[5];帕罗西汀最为常见的不良反应主要有口干、便秘、头痛、视力模糊、头昏、震颤、厌食及体重增加等;曲唑酮常见不良反应主要有镇静,可能伴有不同程度的激动、疲劳、头晕、口干、低血压等,甚至可能出现黄疸、粒细胞减少、肝细胞损伤等。

3.2 药物相互作用:氟西汀和三环类抗抑郁药物若出现相互作用,一般会导致血浆三环类抗抑郁药物浓度的增加,增加倍数近2~5倍,甚至部分患者的抑郁症状会恶化或者出现严重不良反应,比如癫痫发作或者瞻望等;氟西汀与单胺氧化酶抑制剂联用可能引发类5-羟色胺综合征,主要表现为不安、焦虑、寒战、精神错乱、失眠、共济失调等,严重时可能致死(在停用氟西汀后1、2周比较常见);氟西汀与卡马西平等联用也可引发5-羟色胺综合征^[6];氟西汀和非精神病药物联用也能出现相互作用,比如部分心律失常药物与部分 β -肾上腺素能拮抗剂主要由肝细胞色素P-450酶代谢,而氟西汀在一定程度上会抑制该酶的作用产生抑制,从而增强药物效果;氟西汀和美托洛尔联用也能发生类似的相互作用。

4 去甲肾上腺素(NE)能和特异性5-羟色胺5-HT能抑制剂

这类药物主要代表有米氮平与米氮平,其作用特点在于阻断NE能神经元,以及相关的末梢突触前膜 α_2 -自调受体与5-HT能神经末梢突触后膜 α_2 -异调受体,进而对这两种受体产生拮抗作用,促进NE释放与增加5-HT释放。这类药物的常见不良反应与药物相互作用如下:

4.1 不良反应:研究显示米氮平发生不良反应的概率要明显比阿米替林更低,主要包括嗜睡、体重增加、食欲增加、头晕等,发生率约为5%。比如某报道中针对2例服用米氮平后发生不良反应的妇女进行观察,发现1例发生粒细胞缺乏,另外1例出现中性粒细胞减少,但是停药之后皆恢复。

4.2 药物相互作用:米氮平和其他中枢性抗抑郁药物等联用,极易出现运动神经功能损害,故而要减少与乙醇、安定等药物的联用。此外,米氮平也不能与MAO-A联用,若非得联用则要在停用MAO-A药物2周后方可应用米氮平。

5 结语

总的来说,抗抑郁症药物的类型与种类较多,临床常用的药物虽然可以取得一定的效果,但是基本上难以避免不良反应与药物相互作用,除了会对药物的效果产生影响外,还会对患者的生命产生威胁,极大地降低患者的生存质量。为此,临床应加强抗抑郁症药物不良反应及药物相互作用的研究与分析,找出可能出现的不良反应与药物相互作用,从而在临床用药中选择副作用最小而药物疗效也比较良好的抗抑郁症药物处理。同时,应严格掌握抗抑郁药物联合用药指征,积极降低毒副作用与不良反应,促使联用药物治疗的效果达到最佳,而相关的不良反应发生率则降到最低。

参考文献

- [1] 司天梅.米氮平在抑郁症治疗中的作用[J].中华精神科杂志,2013,46(2):116-117
- [2] 安富荣,崔岚.抗抑郁症新药琥珀酸去甲文拉法辛[J].药学服务与研究,2010,10(1):47-50
- [3] 乔卉,安书成,徐畅等.BDNF与抑郁症的研究现状及进展[J].生理科学进展,2011,42(3):195-200
- [4] 段桂花,陈福新.帕罗西汀与抗精神病药物的相互作用[J].四川精神卫生,2013,26(2):141-144
- [5] 杨丽蓉,王志纲.文拉法辛治疗抑郁症的研究进展[J].北方药学,2010,07(1):31-33
- [6] 李晓敏.抗抑郁症药物不良反应及药物相互作用[J].医药前沿,2013,14(33):158-158,159